



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-139547159- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2023-139547159- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. por parte de la firma CIRO HOLDING S.A.

Que la operación fue implementada mediante la compra de la nuda propiedad de acciones representativas del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la firma IKANI S.A. —sociedad holding que es titular de la totalidad de las acciones del INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. — por parte de la firma CIRO HOLDING. S.A.

Que la transacción también supuso la cesión del usufructo sobre las mismas acciones a favor de la firma CIRO HOLDING S.A.

Qu la firma e CIRO HOLDING S.A., previo a la operación notificada, era tenedor del del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones de la firma IKANI S.A., por lo que la operación supone la adquisición del control exclusivo sobre el INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A.

Que el cierre de la transacción se produjo el día 16 de noviembre de 2023 y su notificación ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó con fecha 23 de noviembre de 2023, en tiempo

y forma, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inciso c), de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES \$ 16.255.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442 y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que el 1° de diciembre de 2023, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA requirió al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 17 de la Ley N° 27.442.

Que el organismo requerido no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.

Que se cursaron requerimientos de información a la SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA y el COLEGIO DE CIRUJANOS CARDIOVASCULARES.

Que la primera respondió oportunamente, mientras que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA omitió responder pese a estar debidamente notificada, y respecto del COLEGIO DE CIRUJANOS CARDIOVASCULARES resultó infructuosa la notificación.

Que consecuencia, corresponde dejar sin efecto el requerimiento de información a estas dos últimas entidades.

Que en el marco de la instrucción, la parte notificante acompañó los balances solicitados, sin perjuicio de que el día 9 de abril de 2024 —argumentando evitar un dispendio que consideró innecesario, ya que entendió que con el estado de resultados consolidado de dicha empresa al 31 de diciembre de 2022, surgía claramente que el volumen de negocios del grupo comprador supera el umbral previsto en la normativa aplicable y solicitó la dispensa de presentar los estados contables de todas las empresas que consolida CIRO HOLDING S.A.

Que el Artículo 3, inciso e), del Anexo I – Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica de la Resolución (ex) SECRETARÍA DE COMERCIO N° 905/2013 establece que “la Autoridad de Aplicación podrá considerar que la información y antecedentes proporcionados en el marco de un Procedimiento de notificación resulta suficiente, aun cuando la información exigida por el formulario no haya sido presentada en su totalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 27.442.”

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA considera que los estados contables aportados y toda la información compilada en el expediente resultan suficientes para el análisis económico, por lo tanto, corresponde eximir a la firma CIRO HOLDING S.A. de aportar la documental de los estados contables de las empresas consolidadas por CIRO HOLDING S.A. en el 2022.

Que es por ello que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, entendió que corresponde dispensar a la firma CIRO HOLDING S.A. de acompañar la totalidad de los estados contables y considerar completa la notificación en atención a que, en este caso, la información omitida mencionada en este

apartado no resulta imprescindible para el análisis de la presente operación.

Que la operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. por parte de «Grupo Swiss Medical».

Que el grupo comprador, entre otras actividades, está presente en el sector de la salud a través de la oferta de servicios de medicina prepaga y como operador de distintas clínicas y sanatorios polivalentes localizados en distintas partes del país.

Que debido a que la empresa objeto se dedica a la oferta de servicios de atención sanitaria cardiovascular corresponde evaluar, por un lado, los efectos horizontales que presenta la operación y, por otro, los efectos verticales que se refuerzan a partir de la adquisición.

Que, respecto de la definición del mercado relevante, la prestación de servicios sanatoriales consiste en la atención sanitaria a través de instituciones de financiamiento privado, como clínicas, sanatorios y hospitales, que ofrecen servicios médicos y quirúrgicos a la población.

Que una institución sanitaria puede ser monovalente, es decir, puede estar dedicada exclusivamente a una única área de la medicina, o puede ser polivalente y ofrecer servicios sanitarios relacionados a una amplia variedad de especialidades.

Que los centros monovalentes permiten una concentración de recursos, experiencia y tecnología en un campo específico de la salud, y una institución polivalente está diseñada para abordar una variedad de condiciones médicas en un solo lugar, lo que permite un enfoque de atención y tratamiento a pacientes con múltiples problemas de salud simultáneamente, y con una infraestructura más amplia y diversificada.

Que, desde el punto de vista de la demanda, un centro polivalente es visto como un conglomerado de servicios médicos que atrae a pacientes que necesitan asistencia global o que requieren atención de varias especialidades en un solo lugar, mientras que los pacientes que optan por una institución monovalente ya cuentan, en general, con un diagnóstico previo, lo que orienta la demanda del paciente a la elección de un centro especializado.

Que otra clasificación de las instituciones sanitarias se basa en la complejidad de la atención ofrecida.

Que de acuerdo a lo informado por la parte notificante, para que un sanatorio califique como de alta complejidad debe contar con una unidad de cuidados intensivos, quirófanos y centros de procedimientos aptos para todo tipo de cirugía, en particular cirugías complejas, incluida cardiocirugía y neurocirugía, tecnología avanzada para diagnósticos y tratamientos y equipos médicos especializados, diagnóstico e intervencionismo endovascular, diagnóstico endoscópico, y diagnóstico por imágenes que incluya tomografía y resonancia magnética.

Que el INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. es un centro monovalente de alta complejidad localizado en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires especializado en enfermedades cardiovasculares, cuya atención se centra exclusivamente a pacientes con afecciones cardíacas.

Que dada la actividad desarrollada por la empresa objeto es que a los fines de evaluar los efectos horizontales que presenta esta operación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA acotó el análisis al mercado de prestaciones sanatoriales especializadas en cardiología.

Que dadas las características del servicio ofrecido por los centros médicos de las empresas involucradas y el tipo

de asistencia que mayormente se demanda en los centros especializados, es que, en sintonía con lo definido en antecedentes recientes de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, serán analizados los efectos en el mercado de prestación de servicios sanatoriales especializados en cardiología con un alcance local, acotado a C.A.B.A y Gran Buenos Aires.

Que, al momento de la notificación de la operación, el grupo comprador también co controlaba la empresa de medicina prepaga MEDICUS dado que fue adquirida días previos a la adquisición del INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A.

Que, no obstante, tras una escisión societaria posterior, la firma SWISS MEDICAL S.A. dejó de tener influencia en la actividad de servicios de medicina prepaga que MEDICUS ofrecía.

Que, por lo tanto, a los fines del análisis de esta operación, MEDICUS no será considerada como empresa involucrada.

Que, a los fines de evaluar el efecto vertical mencionado, y dadas las actividades del grupo comprador y la empresa objeto, se estudiará el rol que tiene «Grupo Swiss Medical» en el mercado de medicina prepaga y la probabilidad de que ésta excluya a sus competidores aguas arriba en el mercado de prestación sanatorial cardiológica.

Que los efectos horizontales en el mercado de prestaciones sanatoriales especializadas en cardiología no son significativos desde el punto de vista de defensa de la competencia.

Que, con relación a los efectos verticales de la operación, desde el punto de vista de la prestación de servicios sanatoriales, cada obra social o empresa de medicina prepaga tiene contratado con los prestadores cada servicio por cada plan de manera individual.

Que, no obstante, hay aspectos estructurales de la calidad de la atención sanitaria que no son diferenciables según el paciente que asiste (y su correspondiente cobertura médica), tales como la seguridad de la atención, los equipos de profesionales médicos que atienden, la infraestructura sanitaria y la tecnología del equipamiento, el estándar básico de hotelería, entre otros.

Que, en ese sentido, dadas las características de la operación notificada, y lo descripto previamente, no es esperable que el efecto vertical opere negativamente desde el punto de vista de la calidad.

Que, en consecuencia, atento a que las participaciones de mercado, tanto aguas arriba como aguas abajo no superan el TREINTA PRO CIENTO (30%), se puede afirmar que no hay posibilidad de generar daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados.

Que por todo lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA considera que la operación bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

Que la citada Comisión Nacional advirtió la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

Que las cláusulas restrictivas de la competencia deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, y en este contexto es en el cual deben analizarse los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, considerando los mercados

geográficos y de producto afectados por la operación notificada.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción.

Que, por lo expuesto, la mentada Comisión Nacional concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 24 septiembre de 2025 correspondiente a la “CONC. 1948”, en el cual aconseja a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a) dejar sin efecto el requerimiento de información cursado a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA y al COLEGIO ARGENTINO DE CIRUJANOS CARDIOVASCULARES; b) dispensar a la firma CIRO HOLDING S.A. de acompañar los estados contables referenciados en el apartado II.1 del Dictamen de dicha Comisión Nacional y considerar completo el formulario F0+F1; c) autorizar la operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. por parte de la firma CIRO HOLDING S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

Que, mediante el Decreto N° 650 de fecha 10 de septiembre de 2025, se asignó al señor Secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín LAVIGNE (D.N.I. N° 30.448.069), el ejercicio de las competencias atribuidas a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N.º 27.442, los Decretoa Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y 650/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto el requerimiento de información cursado a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA y al COLEGIO ARGENTINO DE CIRUJANOS CARDIOVASCULARES.

ARTÍCULO 2°.- Dispénsase a la firma CIRO HOLDING S.A. de acompañar los estados contables de las empresas consolidadas por dicha firma en el 2022 y considérese completo el formulario F0+F1.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control

exclusivo sobre el INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. por parte de la firma CIRO HOLDING S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 24 de septiembre de 2025 correspondiente a la “CONC. 1948” identificado con IF-2025-106447674-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.



A LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2023-139547159- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*CIRO HOLDING S.A. E IKANI S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1948)*”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. (“ICBA”) por parte de CIRO HOLDING S.A. (“CIRO HOLDING”).
2. La operación fue implementada mediante la compra de la nuda propiedad de acciones representativas del 50% de IKANI S.A. —sociedad *holding* que es titular de la totalidad de las acciones de ICBA— por parte de CIRO HOLDING. La transacción también supuso la cesión del usufructo sobre las mismas acciones a favor de CIRO HOLDING.
3. Cabe remarcar que CIRO HOLDING, previo a la operación notificada, era tenedor del 50% de las acciones de IKANI S.A., por lo que la operación supone la adquisición del control exclusivo sobre el ICBA.
4. ICBA es un centro médico monovalente de alta complejidad especializado en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares. Sus servicios incluyen consultas ambulatorias especializadas, procedimientos diagnósticos cardiovasculares (electrocardiogramas, ecocardiogramas, estudios hemodinámicos), intervenciones cardiológicas de alta complejidad (cateterismos, angioplastias, colocación de *stents*, ablaciones), cirugía cardiovascular (bypass coronario, reemplazo valvular), y programas de rehabilitación cardíaca.
5. CIRO HOLDING es una sociedad de inversión que actúa como vehículo de inversión del «Grupo Swiss Medical», dedicándose a la adquisición y tenencia de participaciones societarias.
6. El «Grupo Swiss Medical» constituye uno de los principales conglomerados empresariales del sector salud en Argentina, desarrollando actividades de manera integrada en medicina prepaga y prestación de servicios sanatoriales. El grupo posee una red de centros médicos propios distribuidos en el país.¹
7. El cierre de la transacción se produjo el 16 de noviembre de 2023 y su notificación ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 23 de noviembre de 2023.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 23 de noviembre de 2023, CIRO HOLDING notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

¹ Adicionalmente, el grupo desarrolla actividades en sectores como medios de comunicación (*América TV*, *Intensa TV*), seguros generales y de vida, servicios inmobiliarios, seguridad, fideicomisos y agencias de viajes.

9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles — monto que al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (AR\$ 16.255.000.000,00)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley 27.442 y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²
11. El 1 de diciembre de 2023 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que debía adecuarse el formulario F0+F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución SC 905/2023 y que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicándole a la notificante que hasta tanto no adecuara el formulario F0+F1 no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
12. El 1 de diciembre de 2023, esta CNDC requirió al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El organismo requerido no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada..
13. En el marco de la instrucción se cursaron requerimientos de información a la SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA y el COLEGIO DE CIRUJANOS CARDIOVASCULARES. La primera respondió oportunamente, mientras que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA omitió responder pese a estar debidamente notificada, y respecto del COLEGIO DE CIRUJANOS CARDIOVASCULARES resultó infructuosa la notificación. En consecuencia, se deja sin efecto el requerimiento de información a estas dos últimas entidades.
14. El 10 de septiembre de 2025, CIRO HOLDING dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
15. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 10 de septiembre de 2025.

II.1. Solicitud de dispensa

16. En el marco de la instrucción, esta CNDC realizó sendas observaciones al formulario F0+F1, entre ellas, que se aporten todos balances de aquellas empresas que integran el grupo comprador.

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “*A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web*”. El 3 de febrero de 2023, se dictó la Resolución (ex) SCI 63/2023, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (AR\$ 162,55).

17. Oportunamente, la parte notificante acompañó los balances solicitados, sin perjuicio de que el 9 de abril de 2024 —argumentando evitar un dispendio que consideró innecesario, ya que entendió que con el estado de resultados consolidado de dicha empresa al 31 de diciembre de 2022—, surge claramente que el volumen de negocios del grupo comprador supera el umbral previsto en la normativa aplicable y solicitó la dispensa de presentar los estados contables de todas las empresas que consolida CIRO HOLDING.
18. El artículo 3, inc. e), del Anexo I – *Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica* de la Resolución (ex) SC 905/2013 establece que “[l]a Autoridad de Aplicación podrá considerar que la información y antecedentes proporcionados en el marco de un Procedimiento de notificación resulta suficiente, aun cuando la información exigida por el formulario no haya sido presentada en su totalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 27.442.”
19. En este sentido, y dado que esta CNDC considera que los estados contables aportados y toda la información compilada en el presente expediente resultan suficientes para el análisis económico del mismo, corresponde eximir a CIRO HOLDING de aportar la documental los estados constables de las empresas consolidadas por CIRO HOLDING en el 2022.
20. Es por ello que se recomienda al SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO dispensar a CIRO HOLDING de acompañar la totalidad de los estados contables y considerar completa la notificación en atención a que, en este caso, la información omitida mencionada en este apartado no resulta imprescindible para el análisis de la presente operación.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

21. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ICBA por parte de «Grupo Swiss Medical».
22. A continuación, se detallan las actividades de las empresas afectadas en Argentina:

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina.

Compradora	
SWISS MEDICAL S.A.	Asistencia médica integral y comercialización de seguros médicos, seguros generales y seguros de vida.
ECCO S.A.U.	Prestación de servicios de emergencias médicas
INSTITUTO DE SALTA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.U.	Comercialización de seguros de vida
SMG CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A.U.	Comercialización de seguros generales
SWISS MEDICAL ART S.A.U.	Comercialización de seguros de Riesgos del Trabajo
SMG LIFE CIA. DE SEGUROS DE RETIRO S.A.U.	Comercialización de seguros de retiro

SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.U.	Comercialización de seguros de vida
SMG INMOBILIARIA S.A.U.	Inmobiliaria
SMG SERVICES S.A.	Asistencia médica integral. Tiene como proyecto económico la explotación de una clínica en Nordelta que se encuentra en etapa de construcción
MANUTO SEGURIDAD S.A.	Seguridad física
SMG TRAVEL S.A.U.	Servicios minoristas de Agencia de Viajes
INTENSA TV S.A.	Servicio de comunicación audiovisual y radiodifusión
AMERICA TV S.A.	Explotación de servicios de radiodifusión
RED CELESTE Y BLANCA S.A.	Radiotransmisión de onda abierta
JUNIN TV S.A.	Explotación de servicios de radiodifusión
SM GROUP CLINICAS MZA S.A. (etapa preoperatoria)	Servicios de administración, gerenciamiento y explotación de sistemas privados de medicina prepaga, auditoria y contralor de prestaciones médicas
SMG FIDUCIARIA S.A.U.	Constitución y administración de fideicomisos
FIRBIMATIC INTERNACIONAL S.A.	Lavadero industrial
SANATORIO LAS LOMAS S.A. ³	Prestación de servicios sanatoriales
LA PALOMA PRODUCCIONES S.A.	Realización y producción integral de programas de teatro, cinematografía, televisión, radio y cualquier otro tipo de manifestación cultural o publicitaria
BELAIR CONSTRUCCIONES S.A.	Alquiler de inmuebles propios
MANIGAN S.A.	Alquiler de inmuebles propios
BELSIL PRODUCCIONES S.A.	Actividad inmobiliaria y explotación directa de establecimientos rurales
BEIN S.A.	Alquiler de inmuebles propios
FAJUL S.A.	Negociación de vehículos, naves y bienes

³ Se aclara que se encuentran bajo análisis las siguientes operaciones de concentración económica notificadas ante esta CNDC bajo expediente EX-2023-119991836- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*Swiss Medical S.A. y Participaciones Médicas S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC.1938)*” y su acumulado EX-2024-52636601- -APN-DR#CNDC: “*PARTICIPACIONES MEDICAS S.A. Y SWISS MEDICAL S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1975)*” notificadas el 9 de octubre de 2023 y 21 de mayo de 2024, respectivamente. Si bien éstas operaciones no han sido autorizadas a la fecha, se incluyen en el cuadro de empresas afectadas considerando el peor escenario posible, más no puede tomarse ello como prejuzgamiento o adelantamiento de las decisiones que allí se adopten.

	inmuebles, urbanos o rurales, arrendamientos, permutas y administración de propiedades.
INSTITUTO GAMMA S.A. ⁴	Prestación de servicios sanatoriales
HOSPITAL PRIVADO DE ROSARIO S.A. ⁵	Prestación de servicios sanatoriales
LAS VERTIENTES S.A. ⁶	Centro médico de consultas ambulatorias
TERAPIA RADIENTES CUMBRES S.A. ⁷	Tratamientos médicos con radiaciones
MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA ⁸	Asistencia médica y científica
MET CÓRDOBA S.A. ⁹	Asistencia médica integral y comercialización de seguros médicos
Objeto	
ICBA	Centro de salud especializado en atención medica cardiovascular

-
- ⁴ Si bien no fue declarada como empresa afectada por la parte notificante en la presentación del 25 de octubre de 2024, dado que el grupo comprador posee en esta empresa una participación accionaria del 38,84%, la incluyó en la información económica presentada, y que la misma desarrolla actividades que podrían relacionarse con las de la empresa objeto, es que se incluye en el presente cuadro.
- ⁵ Si bien no fue declarada como empresa afectada por la parte notificante en la presentación del 25 de octubre de 2024, ésta es controlada por INSTITUTO GAMMA S.A., por lo que aplican las mismas consideraciones vertidas en la nota anterior.
- ⁶ Idem nota al pie anterior.
- ⁷ Idem nota al pie anterior.
- ⁸ Al momento de la notificación de la presente operación, el grupo comprador también co-controlaba la empresa de medicina prepaga MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA dado que fue adquirida días previos a la adquisición del ICBA. No obstante, tras una escisión societaria posterior, SWISS MEDICAL dejó de tener influencia en la actividad de servicios de medicina prepaga que MEDICUS ofrecía. Por lo tanto, MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA no será considerada como empresa involucrada. La operación citada, tramita bajo expediente EX-2023-119991836- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*Swiss Medical S.A. y Participaciones Médicas S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC.1938)*” y su acumulado EX-2024-52636601- -APN-DR#CNDC: “*PARTICIPACIONES MEDICAS S.A. Y SWISS MEDICAL S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1975)*”, notificadas el 9 de octubre de 2023 y 21 de mayo de 2024, respectivamente. Si bien éstas operaciones no han sido autorizadas a la fecha, se incluyen en el cuadro de empresas afectadas suponiendo una eventual aprobación, más ello no puede tomarse como prejuzgamiento o adelantamiento de las decisiones que allí se adopten.
- ⁹ Se aclara que se encuentran bajo análisis las siguientes operaciones de concentración económica notificadas ante esta CNDC bajo expediente EX-2023-119991836- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*Swiss Medical S.A. y Participaciones Médicas S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC.1938)*” y su acumulado EX-2024-52636601- -APN-DR#CNDC: “*PARTICIPACIONES MEDICAS S.A. Y SWISS MEDICAL S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1975)*” notificadas el 9 de octubre de 2023 y 21 de mayo de 2024, respectivamente. Si bien éstas operaciones no han sido autorizadas a la fecha, se incluyen en el cuadro de empresas afectadas suponiendo una eventual aprobación, más ello no puede tomarse como prejuzgamiento o adelantamiento de las decisiones que allí se adopten.

Fuente: CNDC sobre información aportada por la parte en el presente expediente.

23. El grupo comprador, entre otras actividades, está presente en el sector de la salud a través de la oferta de servicios de medicina prepaga y como operador de distintas clínicas y sanatorios polivalentes localizados en distintos partes del país.
24. Por consiguiente, y en tanto la empresa objeto se dedica a la oferta de servicios de atención sanitaria cardiovascular corresponde evaluar, por un lado, los efectos horizontales que presenta esta operación y, por otro, los efectos verticales que se refuerzan a partir de la adquisición.

III.2. Definición de mercado relevante

III.2.1. Prestación de servicios sanatoriales

25. La prestación de servicios sanatoriales consiste en la atención sanitaria a través de instituciones de financiamiento privado, como clínicas, sanatorios y hospitales, que ofrecen servicios médicos y quirúrgicos a la población.
26. El mercado de servicios de centros de salud ya fue descrito por esta CNDC como “... *el conjunto de todas las entidades privadas de salud con capacidad de internación de pacientes, ya sea que cubran toda la gama de prestaciones clínicas (prestadores polivalentes) o se trate de centros especializados en el tratamiento de patologías específicas*”.¹⁰
27. Considerando la naturaleza de las prestaciones que ofrezca, una institución sanitaria puede ser monovalente, es decir, puede estar dedicada exclusivamente a una única área de la medicina, o puede ser polivalente y ofrecer servicios sanitarios relacionados a una amplia variedad de especialidades.
28. Desde el punto de vista de la oferta, ambos presentan diferencias. Los centros monovalentes permiten una concentración de recursos, experiencia y tecnología en un campo específico de la salud, con un enfoque de la atención para el tratamiento altamente especializada y adaptada a los problemas de esa área concreta, y con una infraestructura diseñada específicamente para soportar la especialidad en cuestión, con equipos y personal dedicados exclusivamente a esa disciplina.
29. Por el contrario, una institución polivalente está diseñada para abordar una variedad de condiciones médicas en un solo lugar, lo que permite un enfoque de atención y tratamiento a pacientes con múltiples problemas de salud simultáneamente. Estos suelen tener una infraestructura más amplia y diversificada, con equipos y servicios que abarcan múltiples especialidades, lo que puede llevar a una mayor complejidad en la gestión de recursos.

¹⁰ “VILLA LARROUDET Y CIA S.A. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 729)”, Resolución (ex) SC 617/09 del 21 de septiembre de 2009, Dictamen CNDC N° 747 del 4 de septiembre de 2009, Expediente S01:0434426/2008.

“OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, DLJMB FUNDING II INC. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 899)”, Resolución (ex) SC 73/13 del 26 de julio de 2013, Dictamen CNDC N° 997 del 4 de junio de 2013, Expediente S01:0148757/2011.

“GALENO ARGENTINA S.A., JULIO ALFREDO FRAOMENI, MAPFRE ARGENTINA HOLDINGS S.A. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1054)”, Resolución (ex) SC 176/16 del 15 de julio de 2016, Dictamen CNDC N° 1234 del 18 de marzo de 2016, Expediente S01:0051527/2013.

Asimismo, aunque desde un centro monovalente los profesionales pueden colaborar con otros especialistas de otras instituciones, un sanatorio polivalente se caracteriza por la interdisciplinariedad, siendo clave que los equipos médicos trabajen en conjunto para abordar una amplia gama de condiciones y necesidades de los pacientes.

30. Desde el punto de vista de la demanda, un centro polivalente es visto como un conglomerado de servicios médicos que atrae a pacientes que necesitan asistencia global o que requieren atención de varias especialidades en un solo lugar, mientras que los pacientes que optan por una institución monovalente ya cuentan, en general, con un diagnóstico previo, lo que orienta la demanda del paciente a la elección de un centro especializado.
31. Otra clasificación de las instituciones sanitarias comúnmente utilizada se basa en la complejidad de la atención ofrecida. De acuerdo a lo informado por la parte notificante, para que un sanatorio califique como de *alta complejidad* debe contar con una unidad de cuidados intensivos (UCI), quirófanos y centros de procedimientos aptos para todo tipo de cirugía, en particular cirugías complejas, incluida cardiocirugía y neurocirugía (exceptuando trasplantes, dado que no es exigible para alta complejidad), tecnología avanzada para diagnósticos y tratamientos y equipos médicos especializados, diagnóstico e intervencionismo endovascular, diagnóstico endoscópico, y diagnóstico por imágenes que incluya tomografía y resonancia magnética.
32. Tanto los centros monovalentes como polivalentes de alta complejidad ofrecen un alto nivel de atención médica, pero lo hacen desde ángulos diferentes en función de sus capacidades y objetivos. Los centros monovalentes permiten la derivación y referencia de pacientes de esa especialidad en particular, por lo que pueden manejar los casos más graves y poco frecuentes con mayor *expertise* que los centros polivalentes de alta complejidad.
33. Dadas las características detalladas, un paciente que quiera consultar y/o tratar una afección particular elegirá una institución entre un conjunto de centros médicos que ofrezcan la misma capacidad y calidad de prestaciones médicas. En ese sentido, puede considerarse que sólo ciertos sanatorios polivalentes de alta complejidad podrían contar con la infraestructura y los recursos suficientes para atender a pacientes de la misma forma que un centro monovalente, lo que hace a esas instituciones ser consideradas como sustitutos cercanos.
34. Resulta importante aclarar que si bien los pacientes son los usuarios finales de la atención sanitaria, en general es necesario contar con una cobertura privada de salud para acceder efectivamente a ese servicio. En otras palabras, la demanda de los servicios de atención médica por parte de los pacientes está mediada por las distintas obras sociales y prepagas, quienes ofrecen coberturas más o menos extensas según el plan elegido. Por lo tanto, la elección de un centro de salud o prestador médico se ve influida por el tipo de cobertura y las características de la cartilla que se tenga.
35. En consecuencia, los principales clientes directos de los centros médicos involucrados son las empresas de medicina prepaga (EMPs) y obras sociales (denominados genéricamente “financiadores de la salud”).
36. Como se describirá en el siguiente apartado, existen actores financiadores —como «Grupo Swiss Medical»— que están integrados verticalmente al ofrecer servicios de medicina prepaga y servicios sanatoriales a través de distintas instituciones médicas.
37. Concretamente, el grupo comprador opera distintas clínicas y sanatorios: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sanatorio de los Arcos, Clínica y Maternidad Suizo Argentina,

Sanatorio Agote¹¹ y Clínica Zabala; en la ciudad de Neuquén, San Lucas Maternidad, Clínica San Lucas Pediátrico, y Clínica San Agustín; en la ciudad de Salta, Sanatorio Altos de Salta; en la ciudad de Rosario, Hospital Privado de Rosario e Instituto Gamma¹²; y, en provincia de Buenos Aires, Clínica Olivos y, recientemente, Sanatorio Las Lomas.¹³ Todos, a excepción de la Maternidad de Neuquén, son centros de salud polivalentes.

38. Por su parte, el ICBA es un centro monovalente de alta complejidad localizado en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires especializado en enfermedades cardiovasculares, cuya atención se centra exclusivamente a pacientes con afecciones cardíacas.¹⁴
39. Los servicios que ofrece este centro de salud monovalente incluye consultas ambulatorias de cardiología (evaluación y tratamiento de enfermedades del corazón y del sistema circulatorio), pruebas diagnósticas cardíacas (electrocardiogramas, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, monitoreo ambulatorio de la presión arterial), intervenciones cardíacas (cateterismo cardíaco, angioplastia coronaria, colocación de *stents*, ablación por catéter, entre otros), cirugía cardíaca (bypass coronario, reparación o reemplazo de válvulas cardíacas, entre otros), rehabilitación cardíaca y prevención cardiovascular. Algunos de estos servicios son de alta complejidad, requieren asistencia especializada e internación, mientras que otros servicios son ambulatorios y de baja complejidad¹⁵.
40. Según la parte notificante, las características determinantes para que ICBA considere a un centro de salud como competidor (o no) son: la cantidad de pacientes cardiovasculares que dicho centro de salud atiende, la reputación y el hecho de ser líder en el campo de la medicina cardiovascular, y/o ser un centro de entrenamiento de cirujanos cardiovasculares.
41. Por todo lo hasta aquí expuesto, dada la actividad desarrollada por la empresa objeto es que a los fines de evaluar los efectos horizontales que presenta esta operación, se acotará el análisis al mercado de prestaciones sanatoriales especializadas en cardiología.
42. Desde el punto de vista geográfico, dada la naturaleza de la actividad económica descripta, debe analizarse si el mercado relevante podría definirse como de alcance local y, en su caso, el radio de alcance que éste tendría. Por lo tanto, corresponde evaluar el área de influencia de los

¹¹ Este sanatorio es polivalente de media complejidad.

¹² Cabe mencionar que, de acuerdo a lo informado a lo largo de la instrucción en el expediente, el grupo comprador no posee control sobre INSTITUTO GAMMA S.A. ni HOSPITAL PRIVADO DE ROSARIO S.A. No obstante, dado que posee tenencias accionarias significativas y toda vez que su actividad económica coincide con el resto de las empresas involucradas (hecho que generó que la parte notificante la incluyera en la información económica presentada) es que a los fines prácticos será considerada para la caracterización del grupo comprador.

¹³ La adquisición del SANATORIO LAS LOMAS S.A. por parte de «Grupo Swiss Medical» está siendo analizada por esta CNDC y tramita bajo el EX-2023-119991836- -APN-DR#CNDC (Conc. 1938) y su acumulado EX-2024-52636601- - PNDR#CNDC (Conc. 1975).

¹⁴ ICBA posee una única sede pero para ordenar la circulación de los pacientes difunden distintas numeraciones de las distintas puertas por la cual los mismos deben ingresar a la institución (para internación, el domicilio es Blanco Encalada 1543/47 (Entre Montañeses y Av. Del Libertador); para Guardia 24hs figura el domicilio Blanco Encalada 1537 (Entre Montañeses y Av. Del Libertador), y como consultorios externos los de los domicilios de Av. Del Libertador 6302 (Esquina Blanco Encalada) y Montañeses 2429 (Entre Monroe y Blanco Encalada), encontrándose todas las direcciones en la misma manzana e interconectadas.

¹⁵ Si bien algunas instituciones cardiovasculares pueden tener servicios médicos generales, el ICBA no los ofrece.

centros de salud involucrados y la distancia que están dispuestos a recorrer los pacientes para recibir atención médica cardiovascular.

43. En primer lugar, merece atención que en los antecedentes citados la definición de mercado geográfico considerada para el mercado de servicios sanatoriales a través de centros de salud tuvo un alcance local, comprendido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, por ser éstas las áreas de influencia de las clínicas involucradas en la operación oportunamente analizada.
44. Vale recordar que el grupo comprador opera sanatorios localizados en distintas partes del país: 4 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 2 en la zona norte de la provincia de Buenos Aires (San Isidro y Olivos), 2 en la ciudad de Neuquén, 2 en la ciudad de Rosario, y 1 en la ciudad de Salta. El ICBA está localizado en CABA.
45. En relación a la distancia que recorrería un paciente para recibir atención médica, la parte notificante señala distintos factores tales como la gravedad de la condición médica, la disponibilidad de servicios en su área local, el acceso al transporte y la comodidad personal del paciente. En este sentido, estiman que para la atención de guardia cardiológica los pacientes recorrían hasta 20 km, para realizarse estudios cardiológicos (electrocardiogramas, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, etc.) hasta 60 km, para consultas médicas - instancia en la que se valora la reputación y/o relación preestablecida con el profesional - hasta 100 km, y para procedimientos más complejos, como intervenciones y cirugías, en los que se valora fuertemente la atención de médicos con experiencia y la capacidad en cuidados intensivos cardíacos, los pacientes podrían estar dispuestos a recorrer hasta 200 km o más.¹⁶
46. En cuanto al área de influencia que efectivamente tiene el ICBA en la actualidad, puede afirmarse que más del 58% de los pacientes reside en CABA, y cerca del 40% proviene de la Provincia de Buenos Aires. El 1,5% restante corresponden pacientes localizados en el resto del país.¹⁷
47. Dadas las características del servicio ofrecido por los centros médicos de las empresas involucradas y el tipo de asistencia que mayormente se demanda en los centros especializados¹⁸, es que, en sintonía con lo definido en antecedentes recientes de esta CNDC, serán analizados los efectos en el mercado de prestación de servicios sanatoriales especializados en cardiología con un alcance local, acotado a CABA y Gran Buenos Aires.

III.2.2. Medicina prepaga

48. En la atención médica privada intervienen 3 actores que interactúan entre sí: pacientes, prestadores de servicios médicos (entre los que se encuentran los descritos en el punto anterior), y los financiadores de la salud, integrados por empresas de medicina prepaga y obras sociales.

¹⁶ Estas estimaciones fueron realizadas por las empresas notificantes, quienes recalcan que las mismas son aproximadas y pueden variar según factores individuales y regionales.

¹⁷ Existe un grupo de pacientes que recibe atención médica virtual. Desde el 2018, ICBA presta servicio de “consulta médica” a distancia. Este servicio se utiliza para brindar soporte a los servicios presenciales existentes, y cubrir aquellas consultas que no requieren revisión física de los pacientes, tales como recetas, entrega de resultados de estudios o seguimiento.

¹⁸ La mayoría de los pacientes atendidos por el ICBA asistió buscando atención ambulatoria y en menor medida atención de guardia (80% y 13,5% respectivamente), servicios en los que se valora la cercanía del centro de salud, mientras que menos del 7% demandó servicios de internación.

49. Los primeros demandan servicios de atención médica a distintos prestadores (sanatorios, laboratorios, profesionales), que son elegidos en función del tipo de cobertura médica que se tenga. Un paciente será atendido en la clínica elegida sólo si cuenta con un plan de salud de alguna empresa que lo incluya en su cartilla.
50. Dentro del sistema de salud argentino, el subsistema privado, de afiliación voluntaria, está integrado por 674 EMP que dan cobertura al 14% de la población argentina. Dentro de este grupo, aproximadamente el 40% adhieren de forma directa (cerca del 5% de la población), mientras que el otro 60% (poco más del 8% de la población) derivan aportes vía planes corporativos o desregulación de obras sociales.¹⁹
51. En efecto, la mayoría de los beneficiarios son trabajadores que aportan a una sola obra social (la de origen o la elegida producto de la opción de cambio), la cual brinda cobertura a través de convenios con entidades de medicina prepaga, o de convenios corporativos celebrados entre las entidades de medicina prepaga directamente con empresas.
52. «Grupo Swiss Medical» actúa como oferente de servicios de medicina prepaga, con 9 planes de salud que brindan distintos tipos de coberturas. Los planes de gama alta (SMG 70, SMG 60, SMG 50, SMG 40 y SMG 30) tienen una cobertura por sistema cerrado y sistema abierto (reintegro) y una amplia cartilla con una gran cantidad de sanatorios y prestadores a nivel país. Por otro lado, los planes SMG 20 y SMG 02 tienen una cartilla intermedia, sin copagos en el primer caso y con un tope en el segundo. Por último, los planes S1 y S2 son planes cerrados con copago, y con una cartilla más limitada en el caso del plan S2.
53. De acuerdo a lo informado por la parte, «Grupo Swiss Medical» también ofrece tres planes parciales exclusivos para beneficiarios de obras sociales, dos de ellos con cobertura ambulatoria exclusiva (que incluye consultas médicas, medicamentos, estudios y prácticas de baja y alta complejidad) y otro que incluye emergencias médicas en domicilio y guardia, internación clínica y quirúrgica y medicamentos en internación.
54. Ciertas empresas de medicina prepaga se encuentran verticalmente integradas en la prestación de servicios sanatoriales, como el grupo comprador —conforme se describió— y otras EMPs como GALENO ARGENTINA S.A. (que opera Sanatorio de la Trinidad y el Sanatorio Dupuytren), OMINT (Clínica Bazterrica, Clínica Santa Isabel, Clínica del Sol), y MEDIFÉ (Sanatorio Finochietto). Existen también prestadores asistenciales que ganaron prestigio y se integraron *hacia delante* ofreciendo planes de salud propios —algunos de estos son el Hospital Alemán o el Hospital Italiano.
55. Como se mencionó antes, al momento de la notificación el grupo comprador también co-controlaba la empresa de medicina prepaga MEDICUS dado que fue adquirida días previos a la adquisición del ICBA. No obstante, tras una escisión societaria posterior, SWISS MEDICAL dejó de tener influencia en la actividad de servicios de medicina prepaga que MEDICUS ofrecía²⁰. Por lo tanto, a los fines del análisis de esta operación, MEDICUS no será considerada como empresa involucrada.

¹⁹ El sistema de salud argentino es tripartito. Por fuera del sector privado, la salud pública cubre aproximadamente al 36% de la población, y la seguridad social integrada por las obras sociales nacionales, provinciales y la de jubilados alcanza al 63,6%. Información en base al Informe de “Coberturas de salud en Argentina”, año 2022, Ministerio de Salud de la Nación.

²⁰ La primera operación fue notificada el 9 de octubre de 2023 y tramita bajo EX-2023-119991836- -APN-DR#CNDC (CONC. 1938), mientras que la posterior escisión mencionada fue notificada el 21 de mayo de 2024, EX-2024-52636601- -APN-DR#CNDC (CONC. 1975) que fue acumulado al primero.

56. Esta CNDC en antecedentes previos²¹ ya analizó el mercado de medicina privada y lo definió como el de comercialización de planes de cobertura médica de salud, con un alcance nacional.
57. Por lo tanto, a los fines de evaluar el efecto vertical mencionado, y dadas las actividades del grupo comprador y la empresa objeto, se estudiará el rol que tiene «Grupo Swiss Medical» en el mercado de medicina prepaga y la probabilidad de que ésta excluya a sus competidores *aguas arriba* en el mercado de prestación sanatorial cardiológica.

III.3. Efectos económicos de la operación

III.3.1. Análisis de los efectos horizontales en el mercado de prestaciones sanatoriales especializadas en cardiología

58. Tal como se detalló antes, la compradora gestiona 12 (doce) sanatorios polivalentes en distintas partes del país, de los cuales 4 (cuatro) se localizan en CABA y 2 (dos) en zona norte del Gran Buenos Aires, mientras que el ICBA, la empresa objeto, cuenta con 1 establecimiento en CABA.
59. De acuerdo a lo informado por la parte notificante, las instituciones que ofrecen los mismos servicios de atención sanitaria cardiovascular que brinda el ICBA son el Hospital Italiano, Fundación Favaloro, Clínica Finochietto, Hospital Británico, Hospital Alemán, CEMIC, FLENI, Hospital Austral, Sanatorio Güemes, Sanatorio Anchorena (Recoleta y San Martín), Sanatorio de la Trinidad, Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. (IADT), y la Clínica Sagrado Corazón. Éstos son centros de salud relevantes que tienen la especialidad de atención cardiológica en el ámbito del AMBA y que, a juicio de ICBA, resultan ser sus competidores.²²
60. Dada la definición de mercado, esta CNDC considera pertinente partir de la caracterización de la competencia realizada por las partes a los fines de analizar la estructura del mercado, considerando el número de camas que opera cada uno de los sanatorios que ofrece servicios

²¹ “GALENO ARGENTINA S.A., JULIO ALFREDO FRAOMENI, MAPFRE ARGENTINA HOLDING S.A. y OTROS”, CONC. 1054 (RESOL-2016-176-APN-SECC#MP); “VILLA LARROUDET Y CIA SA Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156”, CONC. 729 (RESOL-2009-617-APN-SC#MEC); “OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, DLJMB FUNDING II INC. y OTROS”, CONC. 899, (RESOL-2013-73-SC#ME).

²² En el marco de la instrucción del expediente, la parte notificante identificó a los centros médicos competidores de las empresas involucrada: “Es importante aquí recordar que ICBA es una entidad “monovalente”, es decir, solo atiende a pacientes con afecciones cardiovasculares. De modo que este hecho reduce significativamente la cantidad de potenciales competidores, dado que pocos centros de salud en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en condiciones de atender una cantidad de pacientes con patologías cardíacas que pueda considerarse importante o representativa, en relación a la cantidad de pacientes atendidos por ICBA” (...) “Es por ello que ICBA sólo consideró como sus competidores a los centros de salud Hospital Italiano -que, pese a ser un centro polivalente, cuenta con un centro de cardiología muy importante y a la vez es una institución que forma y entrena profesionales especialistas en atención de afecciones cardiovasculares-, Fundación Favaloro, Clínica Finochietto, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, C.E.M.I.C., Sanatorio Mater Dei, Fleni y Hospital Austral, ello en atención al volumen de pacientes cardiovasculares atendidos por dichas instituciones las que, pese a ser polivalentes, cuentan con un servicio de cardiología de importancia, si nos atenemos a la cantidad de pacientes atendidos; descartando otras instituciones que, pese a contar con dicho servicios, no atienden un número de pacientes que ICBA considere relevante o representativo (en relación a la cantidad de pacientes atendidos por ICBA)”.

A partir de esta descripción, se tomaron en consideración aquellos centros de salud que ofrecen los mismos servicios cardiovasculares que el ICBA. Bajo este criterio, no se incluyó al Sanatorio Mater Dei dado que, a pesar de ser un sanatorio de renombre, no realiza cirugías de alta complejidad. Asimismo, se incluyó al Sanatorio Otamendi por ser un centro polivalente con atención cardiovascular localizado en CABA.

cardiológicos, incluyendo a los sanatorios del grupo comprador y objeto que ofrecen los mismos servicios²³, sean estos centros polivalentes o no.

61. A continuación, se detalla la participación de mercado de los sanatorios involucrados en base al número de camas de internación disponibles²⁴.

Tabla 2 | Participación en el mercado de prestaciones sanatorias especializadas en cardiología, CABA y GBA 2024.

Sanatorios	Zona	Nº de camas	Participación
Clínica Zabala	CABA	130	2.08%
Sanatorio de los Arcos	CABA	247	3.95%
Clínica y Maternidad Suizo Argentina	CABA	193	3.09%
Sanatorio Las Lomas	GBA	85	1.36%
Clínica Olivos	GBA	83	1.33%
ICBA	CABA	69	1.10%
GRUPO SWISS MEDICAL+ ICBA		807	12.92%
Otras instituciones con atención cardiológica (*)	CABA+GBA	5396	86.39%
Total instituciones con atención cardiológica (*)	CABA+GBA	6246	100.00%
VAR IHH		27.5	

Fuente: elaboración propia en base a información aportada por la parte notificante y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) - SISA

(*) De acuerdo a la definición de mercado se incluyó a: Hospital Italiano Central, Sanatorio Güemes, Trinidad Mitre, Trinidad Quilmes, Trinidad Palermo, Hospital Alemán, Hospital Británico, Trinidad Ramos Mejía, Trinidad San Isidro, CEMIC, Fundación Favaloro, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, Sanatorio Sagrado Corazón, Hospital Universitario Austral, Sanatorio Anchorena San Martín, Sanatorio Anchorena Recoleta, Sanatorio Otamendi, Sanatorio Finocchietto, Sanatorio Fleni.

62. La participación conjunta en base al número de camas disponibles en CABA y Gran Buenos Aires es de 12,9% para el año 2024.
63. Si se considera que la participación del ICBA es tan sólo del 1,1% y que la variación del IHH es de 27,5 puntos, el impacto que tendrá la operación es poco significativo dado que son valores que se encuentran muy por debajo de lo que esta CNDC considera preocupante en una concentración.²⁵

²³ No se incluyó el Sanatorio Agote, dado que el mismo no ofrece servicios cardiovasculares.

²⁴ Esta unidad de medida es la utilizada en distintas antecedentes para cuantificar la participación de mercado de los centros médicos en el mercado de prestación de servicios sanatorios. Cabe resaltar que es un indicador de capacidad instalada, por lo tanto, son camas de internación potencialmente utilizadas para servicios de cardiología u otra especialidad médica.

²⁵ Por lo general, si el aumento que se produce en el HHI es menor a 150 puntos y la participación conjunta de las empresas involucradas es menor al 50%, la operación de concentración bajo análisis no despertaría preocupaciones desde el punto de la competencia.

64. Cabe mencionar que esta estimación tiene en cuenta sólo a las instituciones de salud que ofrecen servicios cardiológicos de alta complejidad comparables al ICBA, es decir, a las que se consideran sustitutas desde el punto de vista de la demanda.
65. Entre los centros médicos más importantes de la competencia se identifican sanatorios pertenecientes a otros grupos económicos que, al igual que el comprador, se encuentran verticalmente integrados.
66. Es el caso de GALENO ARGENTINA S.A., quien cuenta con la mayor infraestructura de servicios médicos propios —de acuerdo a lo manifestado en su página web— por contar con 7 (siete) sanatorios (entre los Trinidad y el Dupuytren). Este grupo es, en efecto, el que más presencia tiene en servicios sanatoriales del AMBA por ser el que más centros médicos y camas de internación propias posee.
67. Por su parte, OMINT opera la Clínica Bazterrica, Clínica Santa Isabel, Clínica del Sol; MEDIFE controla el sanatorio Finochietto; ACCORD-UP opera los Sanatorios Anchorena (Recoleta y San Martín). Otros sanatorios que ejercen presión competitiva son el Hospital Italiano, Británico y Alemán que ofrecen planes cerrados de medicina prepaga.
68. Por otro lado, el número de médicos cardiólogos empleados en estas instituciones puede ser otro indicador para dimensionar el tamaño del mercado de atención sanatorial especializada en cardiología y, en particular, el peso de las empresas involucradas en el mismo. De acuerdo a la información publicada por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, los profesionales de salud certificados en la especialidad de cardiología fueron 2734 en CABA y 652 en PBA.²⁶ Considerando el número de cardiólogos que declaró emplear el grupo comprador (235) en sus centros médicos y la empresa Objeto (64), la participación sería de 8,8% considerando en conjunto ambas jurisdicciones.
69. Por lo expuesto, los efectos horizontales en el mercado de prestaciones sanatoriales especializadas en cardiología que presenta esta operación no son significativos desde el punto de vista de la competencia.

III.3.2. Análisis de los efectos económicos verticales de la operación

70. Como se dijo previamente, la teoría del daño a evaluar desde el punto de vista vertical es que el «Grupo Swiss Medical», que actúa como EMP y gestiona sanatorios propios, excluya de la atención médica del ICBA a afiliados de otras coberturas médicas. Por lo tanto, resulta necesario evaluar la participación de la compradora en el mercado de medicina privada, y el incentivo que ésta pueda tener para restringir el acceso a la atención sanitaria cardiovascular.
71. A mayo de 2022 (último mes con información disponible) existían 674 EMP que daban cobertura a un total de 6.796.690 personas. A continuación, se presenta el listado de las principales empresas, y sus respectivas participaciones de mercado, en base al número de afiliados a nivel nacional:

²⁶ Información pública publicada en <http://datos.salud.gob.ar>, correspondientes a todas las especialidades (cardiología, cardiología infantil, cirugía cardiovascular, cirugía cardiovascular pediátrica) disponible para el año 2016.

Cabe mencionar que algunos estudios afirman que las estadísticas públicas estarían subestimando el número de especialistas, motivo por el cual las estimaciones podrían estar sobreestimadas.

Tabla 3 | Participación en el mercado de medicina prepaga, año 2022, Nacional.

EMP	Afiliados	Participación
Osde	2116435	31.14%
SWISS MEDICAL S.A.	1004521	14.78%
Galeno Argentina S.A.	565361	8.32%
Asociación Mutual Sancor	528299	7.77%
Omint S.A. de servicios	322634	4.75%
Medifé	212453	3.13%
Accord salud (UPCN)	210156	3.09%
Sociedad Italiana de Beneficencia (Hospital Italiano)	194002	2.85%
Resto	1642829	24.17%
Total	6796690	100.00%

Fuente: Elaboración propia en base a información aportada por la parte notificante y la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

72. El grupo comprador es la segunda EMP más importante del país (en términos de afiliados) siguiendo a OSDE que es el principal oferente de servicios de medicina privada, con el doble de afiliados que SWISS MEDICAL.
73. Por su parte, *aguas arriba*, el ICBA es prestador de más de 180 obras sociales y EMP. De los más de 75.000 afiliados que atendió en el 2023, la mayor cobertura atendida fue la de OSDE, seguida por SWISS MEDICAL, lo cual es coherente con la representatividad de las EMP a nivel nacional.
74. A continuación, se muestra el listado de obras sociales y EMP con las que trabajó ICBA en 2022:

Tabla 4 | EMP y OS atendidas por ICBA, en base a lo facturado, 2022

Financiador	Participación
Osde	44.98%
SWISS MEDICAL S.A.	11.91%
Omint S.A. de servicios	4.32%
MEDICUS	4.27%
Galeno Argentina S.A.	3.39%
Resto	31.13%
Total	100.00%

Fuente: elaboración propia en base a información aportada por la parte notificante

75. Según los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “Lineamientos”) “... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”.²⁷
76. A partir de lo expuesto, puede concluirse *a priori* que es baja la probabilidad de que «Grupo Swiss Medical» excluya a afiliados de otras coberturas de la atención médica del ICBA, dado que el mayor porcentaje de facturación de esta institución se explica por otros financiadores de la salud, distintos a la compradora. En otras palabras, «Grupo Swiss Medical» no tendría el incentivo de perder clientes externos.
77. Asimismo, el mercado de la salud privada en general se organiza con el mayor número de prestadores posible, con una extensa red de servicios propios y/o de terceros. Por tal motivo, y considerando que muchos prestadores están integrados verticalmente, es que «Grupo Swiss Medical» no tendría incentivos a romper relaciones comerciales con otras EMP competidoras que sean, a su vez, importantes prestadores médicos de los planes que ofrezcan.
78. A pesar de lo anterior, cabe mencionar que en caso de que el escenario de cierre vertical sea puesto en práctica, el mismo no tendría la capacidad de generar daños significativos en términos de competencia toda vez que los pacientes que busquen la atención especializada que ofrece el ICBA podrán recurrir al otro 87,1% de oferta disponible, de acuerdo a lo descrito en el apartado anterior.
79. Por último, cabe resaltar que otra forma en la que puede operar el efecto vertical es a través de la degradación de la calidad de atención sanitaria a pacientes con coberturas de terceros (distintos a «Grupo Swiss Medical»).
80. Desde el punto de vista de la prestación de servicios sanatoriales, cada obra social o empresa de medicina prepaga tiene contratado con los prestadores cada servicio por cada plan de manera individual. No obstante, hay aspectos estructurales de la calidad de la atención sanitaria que no son diferenciables según el paciente que asiste (y su correspondiente cobertura médica), tales como la seguridad de la atención, los equipos de profesionales médicos que atienden, la infraestructura sanitaria y la tecnología del equipamiento, el estándar básico de hotelería, entre otros. En ese sentido, dadas las características de la operación notificada, y lo descrito previamente, no es esperable que el efecto vertical opere negativamente desde el punto de vista de la calidad.
81. En consecuencia, atento a que las participaciones de mercado, tanto *aguas arriba* como *aguas abajo* no superan el 30%, se puede afirmar que no hay posibilidad de generar daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados.
82. Por todo lo expuesto, esta CNDC considera que la operación bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.4. Cláusulas de restricciones accesorias

83. Esta CNDC advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

²⁷ Los *Lineamientos* fueron aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el [sitio web](#) de esta CNDC.

84. La «Cláusula 7.2» del *Contrato de Compraventa de la Nuda Propiedad de las Acciones*²⁸ prevé una obligación de no competencia a partir de la celebración del acuerdo y para todo el territorio nacional, que admite excepciones: (i) por cinco (5) años, respecto de ciertos vendedores, incluido el cedente del usufructo mencionado²⁹, que radica en no prestar servicios médicos de cardiología y especialidades afines en la Argentina³⁰; (ii) por dos (2) años respecto de uno de los vendedores³¹, que consiste en no realizar la actividad de prestación de servicios de gerenciamiento y/o administración de establecimientos asistenciales, hospitales, sanatorios o clínicas médicas de internación o salas de primeros auxilios.
85. Vale mencionar que, entre otras cosas y en particular, en la «Cláusula 7.2.6» se encuentra previsto en los términos de dicha cláusula, que dos de los vendedores que son médicos³², puedan atender consultas médicas a pacientes ambulatorios en consultorio particular, siempre y cuando el paciente no haya estado internado en el ICBA y que, para el caso de que los pacientes requieran la prestación de servicios médicos, éstos sean derivados por ambos profesionales para su atención en el ICBA.
86. Además, dicha cláusula de no competencia incluye una disposición de no captación de empleados y/o clientes y/o proveedores de IKANI y/o de ICBA para los vendedores y el cedente de usufructo («Cláusula 7.2.5»).
87. En respuesta a observaciones efectuadas oportunamente por esta CNDC, CIRO HOLDING justificó el plazo de duración de la cláusula de no competencia indicando que éste es usual y razonable para este tipo de transacciones y que tiene el fin de preservar el valor de la inversión efectuada por la compradora.
88. Aclaró también que, conforme surge de la «Cláusula 7.2», específicamente, (i) los vendedores Jorge Atilio y Andrés Guillermo BELARDI, pueden seguir prestando los servicios alcanzados por la prohibición de competencia tanto a ICBA como a otras sociedades controladas por el grupo comprador; (ii) los vendedores Jorge Atilio y Diego Fernando BELARDI (quien reside en Estados Unidos), ambos médicos cardiólogos, pueden atender consultas médicas a pacientes ambulatorios en sus consultorios particulares; y (iii) el vendedor Diego Fernando BELARDI puede prestar servicios de cardiología en Argentina incluso durante el plazo durante el cual rige la obligación de no competir, con la salvedad que primero debe notificar a ICBA a fin de que entre ambas partes procuren ponerse de acuerdo sobre los términos bajo los cuales el profesional preste servicios en ICBA y, para el caso de que no arribaren a un acuerdo, dicho profesional podrá prestar servicios de cardiología en otros hospitales, clínicas o centros de salud del país, en términos no menos favorables que los ofrecidos a ICBA.
89. Ahora bien, esta CNDC observó el formulario F0+F1 en sendas ocasiones a fin de que CIRO HOLDING justifique la razón por la cual la «Cláusula 7.2.6» del instrumento de la operación

²⁸ Si bien CIRO HOLDING solicitó la confidencialidad parcial de este instrumento, no lo hizo respecto de las cláusulas y además ratificó que en el formulario F0+F1 presentado, donde realizó una transcripción de las mismas, no se consignó ningún dato confidencial.

²⁹ Jorge Ignacio BELARDI, Diego Fernando BELARDI, María Cecilia BELARDI y Jorge Atilio BELARDI, respectivamente.

³⁰ Incluye ser director, empleado, socio, consultor, asesor, mandatario, representante o agente de cualquier sociedad, vehículo o entidad que se dedique a dichas actividades.

³¹ Andrés Guillermo BELARDI.

³² Jorge Atilio BELARDI y Diego Fernando BELARDI.

involucra a terceros ajenos a la operación al estipular la derivación al ICBA de los pacientes ambulatorios atendidos en el consultorio particular de los doctores Jorge Atilio y Diego Fernando BELARDI, que requieran la prestación de servicios médicos.

90. En este sentido, CIRO HOLDING entendió razonable que, en el contexto de la excepción al compromiso de no competir, se haya acordado que los pacientes particulares de los mentados profesionales sean derivados a ICBA, reiterando que es en aras de preservar la inversión efectuada por la compradora.
91. Argumentó que, toda vez que el doctor Diego Fernando BELARDI reside en el exterior y la «Cláusula 7.2.6» está circunscripta a la República Argentina, en definitiva, únicamente resulta aplicable a Jorge Atilio BELARDI. Expuso que dicho profesional, por ser fundador del ICBA y una “eminencia” en el campo de afecciones cardiovasculares, podría recrear lo que hizo con dicha empresa con cualquier otro establecimiento.
92. Agregó que, conforme surge del instrumento, dicho profesional puede atender sin inconveniente pacientes en forma particular y que la derivación al ICBA —en el caso de éstos requieran cirugías o tratamientos médicos no ambulatorios— no coarta la libertad de elección del paciente ya que si dicho profesional quiere asistirlo en otro centro de salud podría hacerlo y CIRO HOLDING no podría oponerse a ello válidamente.
93. Puso énfasis en que los pacientes no son objeto de la estipulación contractual por no haber asumido compromiso alguno y por ende no se encuentra restringida su elección y que únicamente se encuentran alcanzados por el compromiso de derivación Jorge Atilio y Diego Fernando BELARDI. También adujo que la «Cláusula 7.2.6.» no limita ni afecta la libre elección de los pacientes, en ningún caso los obliga a atenderse en el ICBA, pudiendo hacerlo en donde elijan libremente, pudiendo optar por otros centros de salud si así lo prefieren.
94. Las cláusulas restrictivas de la competencia deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia. En este contexto es en el cual deben analizarse los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, considerando los mercados geográficos y de producto afectados por la operación notificada.
95. En este caso y, según se ha expuesto en la sección precedente, esta CNDC no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

96. Por lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
97. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
 - (a) dejar sin efecto el requerimiento de información cursado a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA y al COLEGIO ARGENTINA DE CIRUJANOS CARDIOVASCULARES,

- (b) dispensar a CIRO HOLDING S.A. de acompañar los estados contables referenciados en el apartado II.1 y considerar completo el formulario F0+F1, y
 - (c) autorizar la operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. por parte de CIRO HOLDING S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
98. Elévese el presente dictamen a la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, para su conocimiento.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1948 - Dictamen - Autoriza, artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.